

УДК:616-006.329

Е.Ш.Абзалбек

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Отдаленные результаты трехмодальной терапии рака пищевода

Аннотация. Лечение рака пищевода до сих пор остается сложной проблемой клинической онкологии. В данной статье авторы представили результаты комплексной терапии рака пищевода. Изучена частота выживаемости после трехмодального (химиотерапия + облучение + операция) лечения.

Ключевые слова: рак пищевода, хирургическое лечение, отдаленные результаты.

Введение. В Республике Казахстан в год выявляется около 1200 больных раком пищевода, погибает около 1000 человек в год [2].

Лечение рака пищевода остается одной из наиболее сложных проблем современной онкологии. Это обусловлено поздней диагностикой опухолевого процесса, когда доля больных имеющих уже местно-распространенный процесс на момент обращения к врачу составляет 70-80% [1].

Основным радикальным методом лечения рака пищевода является хирургический. Однако этот метод оказывается эффективным лишь при ранних стадиях заболевания. Одной из основных неудач в лечении является большая местная распространенность опухолевого процесса на момент обращения за специализированной помощью. Таким образом, при местно-распространенных опухолях пищевода низкий процент резектабельности не позволяет у большинства больных выполнить радикальное хирургическое вмешательство, то есть применение только лишь одного локального метода воздействия оказывается недостаточным [3].

Другим направлением в поиске наиболее оптимального вида лечения рака пищевода является применение предоперационной комбинации лекарственного и лучевого воздействия на опухоль с последующей операцией – мультимодальная (тримодальная) терапия [4].

Предоперационная химиолучевая терапия рака пищевода приобретает большое значение, так как может быть применена у большинства больных как компонент комплексного метода лечения местно-распространенного процесса. Ее основной целью является увеличение количества радикальных резекций, подавление субклинических метастазов, уменьшение рисков развития отдаленных метастазов и, как следствие, увеличение продолжительности жизни и улучшение результатов лечения в целом [5].

Отсутствие единого мнения о целесообразности и эффективности проведения предоперационной терапии, методах профилактики послеоперационных осложнений у больных раком пищевода явилось предпосылкой для проведения нашего исследования.

Цель исследования - Улучшение результатов лечения местнораспространенного рака пищевода.

Материал и методы. Проведено лечение 107 больным местнораспространенным раком пищевода, из которых 54 больным (основная группа) назначена мультимодальная терапия – неоадъювантная полихимиотерапия (3 кур-

са) + лучевая терапия + операция и 53 пациентам – только хирургическое лечение. Средний возраст больных в группе мульти модального лечения составил $53,5 \pm 25,5$ лет, в группе хирургического лечения – $57,5 \pm 20,51$ лет. Полихимиотерапия проводилась по схеме: доцетаксел – 75 мг/м² 1 день + цисплатин 75 мг/м² 1 день 3 курса с интервалом между курсами 3 недели. Параллельно 3 курсу проводилась лучевая терапия РОД – 2 Гр, СОД – 50 Гр. Последним этапом для мультимодальной терапии выполнялось оперативное вмешательство в объеме субтотальной резекции пищевода с гастрозофагопластикой со стандартной двухзональной лимфодиссекцией.

Результаты и их обсуждение. Во время проведения мультимодальной терапии 2 пациента выбыли из программы лечения в связи с прогрессированием процесса на этапе между 2 и 3 курсами полихимиотерапии, им произведено оперативное лечение. При проведении неоадъювантной химиолучевой терапии в основной группе эффективность терапии отмечена в 61,5%. Патоморфоз III-IV степени достигнут в 32,7%, I-II в 57,7%. Токсичность химиолучевой терапии отмечалась I и II степени, за счет эмитических реакций и не лимитировала проведение мультимодальной терапии.

Во всех 105 случаях выполнена субтотальная резекция пищевода. При хирургическом методе лечения у 13 больных из 53 отмечено 15 ($28,4 \pm 0,46$) различного рода осложнений. Наиболее часто встречалась послеоперационная пневмония (4) ($20,8 \pm 0,24\%$). В 2-х случаях летальный исход, в первом случае по причине инфаркта миокарда (1,9%), во втором случае РДС (1,9%).

В основной группе у 15 пациентов из 52, отмечены 16 осложнений (30,7%). Превалирующее число осложнений принадлежит послеоперационной пневмонии (9 больных – $17,4 \pm 0,22\%$). В данной группе так же отмечена летальность в 2 случаях. В первом по причине РДС (3,8%), во втором за счет несостоятельности ПЖА (1,9%).

Прослежена годичная выживаемость у 101 больных из 105, переживших ранний послеоперационный период и пролеченных по сравниваемым схемам. Хирургическую группу составили 51 больных, в группе мультимодальной терапии отслежены ближайшие (2 года) и отдаленные (5 лет) результаты лечения для 50 пациентов.

По данным авторов, изучавших отдаленные результаты, при хирургическом лечении более 50% рецидивов и метастазов у больных возникают в первые два года после операции. Этот срок для больных раком пищевода III и более стадии является критическим в отношении прогрессирования заболевания. В таблице 1 представлены данные о двухлетней выживаемости изучаемых групп больных.

Таблица 1 - Двухгодичная выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	2-летняя выживаемость	Безрецидивная 2-летняя выживаемость
Хирургический	51	23	28 (54,9 ± 3,65)	24 (47,5 ± 3,55)
Мультимодальный	50	20	30 (60 ± 3,65)	28 (53,8 ± 3,65)

Отмечается увеличение количества пациентов, переживших двухлетний срок наблюдения без мета-стазов и рецидивов при мультимодальном лечении – 53,8±3,65 против – 47,5±3,55 при хирургическом. Аналогично, отмечается увеличение общей выживаемости в группе мультимодального лечения – 60,0±3,65 по сравнению с 54,9±3,65 при хирургическом.

Пятилетние результаты лечения прослежены также у 101 больного (см. таблицу 2).

Таблица 2 - Пятилетняя выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	5-летняя выживаемость	Безрецидивная 5-летняя выживаемость
Хирургический	51	42	9 (18,9 ± 3,80)	8 (17 ± 3,65)
Мультимодальный	50	34	16 (32,7 ± 4,15)	14 (28,8 ± 3,90)

В группе хирургического лечения по настоящее время живы 9 (18,9±3,80) человек, в то время как в группе мультимодальной терапии пятилетний рубеж перешагнули 16 (32,7±4,15) пациентов. Безрецидивная пятилетняя выживаемость также выше в группе мультимодальной терапии - 28,8±3,90 против 17±3,65 в группе хирургического лечения. Отмечается снижение темпов смертности после лечения как в группе хирургического, так и в группе мультимодального лечения в сравнении первых двух и последующих 3 лет. Так, если в первые 2 года умерло 37,2% и 32,0% больных в группах хирургии

и мультимодальной терапии, то в последующие годы эти цифры составили 31,3% и 30,0% соответственно. Эти показатели соответствуют литературным данным о наибольшем обнаружении прогрессирования опухолевого процесса и смертности пролеченных больных именно в первые два года после радикального вмешательства.

Закключение. Таким образом, проведение мультимодальной терапии больным с местнораспространенными формами рака пищевода не ухудшает непосредственные результаты, а увеличивает частоту выживаемости в отдаленном периоде.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М., Исмаилов С.Б. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2013 году (статистические материалы).- Алматы, 2014.
2. Давыдов М.И., Стилиди И.С., Свиридова С.П. и др. Непосредственные результаты расширенных операций с двух- и трехзональной лимфодиссекцией в хирургическом лечении рака пищевода //Мат. юбилейной конф. «Проблемы современной онкологии». – Томск, 1999. – С.82-85.
3. Adelstein D.J., Rice T.W., Rybicki L.A. et al. Concurrent chemo radiotherapy and surgery for esophageal cancer: updated results //Can. J. Gastroenterology. – 1998. – Vol.12 (Suppl B). – A26 (abstr.).
4. Bosset J.F., Gignoux M., Triboulet J.P. et al. Chemoradiotherapy followed by surgery compared with surgery alone in squamous-cell cancer of the esophagus // N. Engl. J. Med. - 2003. -Vol. 337.-P.161-167.
5. Parkin D.M., Bray F., Ferlay J., Pisani P. Global cancer statistics // CA Cancer J. Clin. – 2005. – Vol.55. – P.74-108.

Тұжырым
Е.Ш.Абзалбек

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ,

Өңеш қатерлі ісігі үшмодальды терапиісының алыстанған нәтижелері

Өңештің қатерлі ісігі қазіргі кезге дейін клиникалық онкологияда аса күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мақалада авторлар өңештің қатерлі ісігінің комплексті емінің нәтижелерін көрсетті. Үшмодальды емнің (химиотерапия + сәулелік ем + операция) өмір сүру жиілігі зерттелінді.

Түйінді сөздер: өңештің қатерлі ісігі, хирургиялық ем, алыстанған нәтижелер.

Summary
E.Sh. Abzalbek

Kazakh Research institute of Oncology and Radiology

Treatment of esophageal cancer is still a difficult problem of Clinical Oncology

In this article the authors presents the late results and survival rate in esophageal cancer after complex (chemotherapy + radiation + surgery) therapy.

Key words: esophageal cancer, surgical treatment, late results.